2026–2027 AKADEMİK YILI · DÖNEM 3 KURUL 1 (ÜROGENİTAL VE OBSTETRİK KURULU)

2026–2027 Dönem 3 Kurul 1 Çıkmış Soruları (1–100 Sınav Düzeni)

SINAV KİTAPÇIĞI (ÇÖZÜMSÜZ TEST DÜZENİ + SONDA CEVAP ANAHTARI · 1–100)

📋 Toplam Sınav Kapasitesi: 100 Soru

✅ Hatırlanan ve Doğrulanan: 64 Soru (52 Kesin Sıra + 12 Branş İçi)

⬜ Henüz Hatırlanmayan (Boş Bırakılan): 36 Soru

📚 Kaynak: 23 Ekim 2026 Cuma WhatsApp Paylaşımları + Kurul 1 Amfi Ders Notları

SORU 1–12 (12 SORU)

Tıbbi Genetik

5 Mevcut (4 kesin no, 1 branş içi)

7 Boş

SORU 13–34 (22 SORU)

Enfeksiyon Hastalıkları

14 Mevcut (9 kesin no, 5 branş içi)

8 Boş

SORU 35–68 (34 SORU)

Tıbbi Patoloji

25 Mevcut

(23 kesin no, 2 branş içi) 9 Boş

SORU 69–78 (10 SORU)

Halk Sağlığı

6 Mevcut (4 kesin no, 2 branş içi)

4 Boş

SORU 79–90 (12 SORU)

Üroloji

8 Mevcut (7 kesin no, 1 branş içi)

4 Boş

SORU 91–96 (6 SORU)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 Mevcut (3 kesin no, 0 branş içi)

3 Boş

SORU 97–100 (4 SORU)

Tıbbi Farmakoloji

3 Mevcut (2 kesin no, 1 branş içi)

1 Boş

SORU 1 – 12 BLOĞU (12 SORU)

Tıbbi Genetik

5 / 12 Soru Mevcut

7 Boş Yuva

SORU 1

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 2 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#2)

Yapısal Kromozom Anomalileri (Cri du Chat Sendromu - 5p Delesyonu)

2) Yenidoğan döneminde karakteristik yüksek perdeli, tiz (kedi miyavlaması benzeri) ağlama sesi, mikrosefali, hipertelorizm, epikantal katlantılar, düşük kulak yerleşimi ve ağır psikomotor gelişme geriliği bulguları saptanan bir bebekte yapılan sitogenetik analizde 5. kromozomun kısa kolunda terminal delesyon (46,XX,del(5)(p15)) tespit edilmiştir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wolf-Hirschhorn sendromu

B) Cri du chat (Kedi miyavlaması) sendromu

C) DiGeorge (Velokardiyofasiyal) sendromu

D) Prader-Willi sendromu

E) Williams-Beuren sendromu

SORU 3

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 4 | Tıbbi Genetik | ✓ Kesin Sınav Sırası (#4)

Prenatal Tanı ve Birinci Trimester Nukal Translusensi (NT) Tarama Bulguları

4) Birinci trimester prenatal ultrasonografik incelemesinde Nuchal Translucency (NT - ense saydamlığı) artışı saptanan bir fetusta aşağıdaki genetik veya kromozomal durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Trizomi 21 (Down sendromu)

B) Trizomi 13 (Patau sendromu)

C) Trizomi 18 (Edwards sendromu)

D) 45,X (Turner sendromu)

E) 47,XXY (Klinefelter sendromu)

SORU 5

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 6 Tıbbi Genetik ✓ Kesin Sınav Sırası (#6)

Gonadal Gelişim ve Cinsiyet Belirlenmesinde Rol Oynayan Genler (WNT4 ve DAX1)

6) Embriyonik dönemde bipotansiyel gonadın dişi yönünde (over) farklılaşmasında rol oynayan ve SRY-SOX9 yolağını baskılayarak testis gelişimini engelleyen gen ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SRY ve SOX9

B) WNT4 ve DAX1 (NR0B1)

C) AMH ve DMRT1

D) SF1 ve WT1

E) FGF9 ve DHH

SORU 7

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 8 Tıbbi Genetik ✓ Kesin Sınav Sırası (#8)

Ürogenital Sistem Tümörlerinde Serum Biyobelirteçleri (AFP, β-hCG ve LDH)

8) Serumda alfa-fetoprotein (AFP), insan koryonik gonadotropini (β-hCG) ve laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerinin birlikte değerlendirilmesinin tanı, evreleme, prognoz tayini ve tedavi yanıtının izleminde temel biyobelirteç paneli olarak kullanıldığı ürogenital sistem malignitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane kanseri

B) Prostat kanseri

C) Seröz over karsinomu

D) Testis kanseri (Testiküler germ hücreli tümörler)

E) Endometriyum kanseri

SORU 9

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 10 | Tıbbi Genetik | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #10 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Kalıtsal Meme ve Over Kanseri Sendromu (BRCA1 ve BRCA2 Gen Mutasyonları)

10) Homolog rekombinasyon yoluyla çift zincir DNA kırıklarının tamirinde görev alan BRCA1 (17q21) ve BRCA2 (13q12) tümör baskılayıcı genlerindeki kalıtsal (germ-line) mutasyonlar, en belirgin olarak aşağıdaki kanser ikililerinden hangisinin gelişme riskini artırır?

A) Meme kanseri ve over (yumurtalık) kanseri

B) Kolorektal kanser ve mide kanseri

C) Medüller tiroid kanseri ve feokromositoma

D) Berrak hücreli böbrek kanseri ve hemanjiyoblastom

E) Retinoblastom ve osteosarkom

SORU 11

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 12

Tıbbi Genetik (1–12) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 13 – 34 BLOĞU (22 SORU)

Enfeksiyon Hastalıkları

14 / 22 Soru Mevcut | 8 Boş Yuva

SORU 13

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 14 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#14) | Bakteriyel Vajinozis Tanısı ve Amsel Kriterleri

14) Bakteriyel vajinozis klinik tanısında kullanılan Amsel kriterleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vajinal duvarı kaplayan ince, homojen, gri-beyaz renkli vajinal akıntı görülmesi

B) Vajinal akıntı pH değerinin 4,5'in üzerinde (pH > 4,5) olması

C) Vajinal sekresyona %10 potasyum hidroksit (KOH) eklendiğinde balık kokusu duyulması (pozitif Whiff testi)

D) Islak preparat veya Gram boyamada epitel hücrelerinin en az %20'sinin ipucu hücresi (clue cell) olması

E) Direkt mikroskopide vajinal sürüntüde yoğun polimorfonükleer lökosit (PNL) hakimiyetinin ve vajen duvarında şiddetli inflamasyonun saptanması

SORU 15

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 16 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #16 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Bulaş Yoluna Yönelik Önlemler: Damlacık İzolasyonu Kuralları

16) Damlacık izolasyonu uygulanan bir hastanın bakımı sırasında sağlık çalışanının hastaya 1 metreden daha yakın mesafede çalışırken alması gereken önlem ve hastanın oda dışına nakli (transportu) gerektiğinde uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Odaya girerken el hijyeni, hastaya 1 metreden yakın mesafede tıbbi maske/önlük/eldiven/göz koruyucu kullanımı; taşıma esnasında hastaya cerrahi (tıbbi) maske takılması

B) Negatif basınçlı izole oda ve N95/FFP3 partikül tutucu maske kullanımı; taşıma esnasında hastaya N95 maske takılması

C) Odaya girerken yalnızca steril pudralı eldiven giyilmesi; taşıma esnasında hastaya maske takılmaması

D) Kişisel koruyucu ekipmanların hasta odasından çıktıktan sonra koridorda çıkarılması; taşıma esnasında hastaya oksijen çadırı uygulanması

E) Aynı odadaki farklı tanılı hastalar arasında en az 10 santimetre mesafe bırakılması; taşıma esnasında sağlık çalışanının galoş giymesi

SORU 17 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#17) | Hepatit B Temas Sonrası Profilaksi İlkeleri

17) HBsAg pozitif olduğu bilinen bir kaynak hasta ile perkütan veya mukozal yoldan riskli teması olan, daha önce Hepatit B aşısı yapılmamış (aşılanmamış) bir kişide uygulanması gereken temas sonrası profilaksi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca tek doz Hepatit B immünglobulini (HBIG) uygulanması

B) Yalnızca Hepatit B aşılama şemasına (0, 1 ve 6. ay) başlanması

C) 1 doz Hepatit B immünglobulini (HBIG) verilmesi ve eş zamanlı olarak Hepatit B aşılama şemasına başlanması

D) Profilaksi verilmeyip 1. ayda Anti-HBs ve HBsAg kontrolü yapılması

E) 1 ay ara ile 2 doz HBIG verilip aşılama yapılmaması

SORU 18

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 19 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #19 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Beta-Laktam Dirençli Bakteriler (GSBL ve MRSA) ve Tedavi İlkeleri

19) Beta-laktam grubu antibiyotiklere direnç geliştiren bakteriler (Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz [GSBL] üreten Gram-negatif basiller ve Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus [MRSA]) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) GSBL üreten bakteriler penisilinleri ve oksiimino-sefalosporinleri (sefotaksim, seftriakson, seftazidim, sefepim) hidrolize ederek etkisizleştirir

B) GSBL üreten bakterilerin neden olduğu ağır enfeksiyonların tedavisinde karbapenem grubu antibiyotikler (imipenem, meropenem, ertapenem) kullanılır

C) MRSA suşları, penisilin bağlayan protein (PBP2a) değişimi nedeniyle tüm penisilinlere, sefalosporinlere ve karbapenemlere dirençlidir

D) Beta-laktam dirençli bakteriler (MRSA ve GSBL üreten suşlar), 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir

E) MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde vankomisin, teikoplanin, linezolid veya daptomisin tercih edilir

SORU 20 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#20)

Sifiliz Evreleri ve Sekonder Sifiliz Klinik Bulguları

20) Treponema pallidum enfeksiyonunun klinik seyri sırasında gelişen aşağıdaki lezyon ve bulgulardan hangisi sekonder sifiliz evresinde görülmez?

A) El içi ve ayak tabanını da tutan, kaşıntısız, simetrik makülopapüler deri döküntüsü

B) Perine, vulva ve skrotum gibi nemli bölgelerde gelişen bulaştırıcı kondiloma lata plakları

C) Yaygın, ağrısız lenfadenopati (özellikle epitroklear ve inguinal lenf bezlerinde büyüme)

D) Kıl foliküllerinin tutulumuna bağlı kaş dökülmesi ve güve yeniği tarzında alopesi

E) Deri, kemik ve karaciğerde doku yıkımına yol açan granülomatöz gom (gommatöz) lezyonları

SORU 21

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 22 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#22)

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ateşli Hastaya Yaklaşım İlkeleri

22) Antimikrobiyal yönetim ve akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce enfeksiyon odağına uygun mikrobiyolojik kültür örnekleri alınmalıdır

B) Klinik ve laboratuvar bulgularla bakteriyel enfeksiyon tanısı konmuş hastalarda etkeni kapsayan en dar spektrumlu antibiyotik seçilmelidir

C) Seçilen antibiyotiğin dozu, uygulama yolu ve tedavi süresi hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları dikkate alınarak belirlenmelidir

D) Poliklinik ve acil servis başvurularında ateşi olan her hastaya zaman kaybetmeden ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır

E) Gereksiz ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, dirençli bakteri suşlarının seçilmesine ve normal mikrobiyota dengesinin bozulmasına yol açar

SORU 23 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#23)

Hepatit B Taşıyıcısı Annenin Yenidoğan Bebeğinde Perinatal Profilaksi

23) HBsAg pozitif (Hepatit B taşıyıcısı) olan bir anneden doğan yenidoğan bebekte perinatal Hepatit B bulaşını önlemek için uygulanması gereken en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca Hepatit B aşısının yapılması yeterlidir

B) Doğumda profilaksi vermeye gerek yoktur, bebek 1. ayda serolojik test ile kontrol edilir

C) Yalnızca Hepatit B immünglobulini (HBIG) uygulanması yeterlidir

D) Yenidoğana doğumdan hemen sonra oral antiviral tedavi başlanır

E) Hepatit B aşısı ve Hepatit B immünglobulini (HBIG) doğumdan hemen sonra birlikte uygulanır

SORU 24

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 25 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #25 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Akut Komplike Olmayan Sistit Klinik Bulguları (Ateş Yokluğu)

25) Akut komplike olmayan sistit (alt üriner sistem enfeksiyonu) tablosunda aşağıdaki klinik belirti ve bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?

A) İdrar yaparken yanma ve ağrı (Dizüri)

B) Sık aralıklarla idrara çıkma (Pollakiüri / Frequency)

C) Ani ve ertelenemez idrar yapma isteği (Urgency)

D) Suprapubik bölgede ağrı ve hassasiyet

E) Yüksek ateş (>38 °C), üşüme-titreme ve kostovertebral açı hassasiyeti

SORU 26

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 27 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #27 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Sifiliz Klinik Evreleri, Kondiloma Lata, Şankr ve Tedavi Özellikleri

27) Sifilizin (Treponema pallidum enfeksiyonunun) klinik evreleri, bulguları ve tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sekonder sifiliz evresinde vulva, skrotum ve perinede gri-beyaz verrüköz plaklar şeklinde kondiloma lata lezyonları görülür ve oldukça bulaştırıcıdır

B) Primer sifiliz evresinde bakteri giriş yerinde gelişen şankr, kenarları düzensiz, tabanı yumuşak ve şiddetli ağrılı bir ülserdir

C) Latent sifiliz evresinde hastada aktif klinik semptom bulunmadığından daha önce tedavi almamış olsa bile antibiyotik tedavisi verilmez

D) Tersiyer (geç) sifiliz evresinde görülen gom lezyonları yoğun spiroket içerdiğinden hastalığın en bulaştırıcı lezyonlarıdır

E) Primer ve sekonder sifiliz tedavisinde Treponema pallidum penisiline doğal dirençli olduğundan ilk tercihte vankomisin kullanılır

SORU 28

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 29 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#29) | Prionlar ve İnsanlarda Görülen Prion Hastalıkları

29) Nükleik asit (DNA veya RNA) içermeyen, fiziksel ve kimyasal inaktivasyona dirençli küçük enfeksiyöz proteinler olan prionların insanlarda oluşturduğu hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD)

B) Kuru

C) Deli dana hastalığı (Bovin spongiform ensefalopati / varyant CJD)

D) Ölümcül ailevi uykusuzluk (Fatal familial insomnia)

E) Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)

SORU 30

Enfeksiyon Hastalıkları (13–34)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 31 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#31)

Üriner Sistem Enfeksiyonları Patogenezi ve Etken Dağılımı

31) Üriner sistem enfeksiyonlarının (ÜSE) etiyopatogenezi ve bulaş yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mikroorganizmalar üriner sisteme en sık enfekte bir odaktan hematojen yayılım yoluyla ulaşır

B) Üriner sistem enfeksiyonlarının en sık etkeni olan Escherichia coli, sıklıkla periüretral bölgeden asendan (yükselen) yolla enfeksiyona neden olur

C) Mesanenin tam boşalamaması ve rezidüel idrar kalması, bakteriyel kolonizasyonu azaltan koruyucu bir faktördür

D) Komplike olmayan toplum kökenli akut sistit olgularında en sık izole edilen etken Pseudomonas aeruginosa'dır

E) Erkeklerde üretranın kısa olması ve anüse yakınlığı nedeniyle yaşamın ilk yılından sonra ÜSE sıklığı kadınlardan daha yüksektir

SORU 32 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#32)

Akut Piyelonefrit Klinik Tanısı ve Tedavide Kullanılmayan Antibiyotikler

32) Yirmi sekiz yaşında kadın hasta; 2 gündür devam eden idrar yaparken yanma, üşüme-titreme, yüksek ateş ve sağ yan ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 38,8 °C ve sağ kostovertebral açı hassasiyeti (KVAH) pozitif saptanıyor. Tam idrar tetkikinde piyüri ve nitrit pozitifliği tespit edilen bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi kullanılmaz?

A) Siprofloksasin

B) Seftriakson

C) Fosfomisin trometamol

D) Ertapenem

E) Piperasilin-tazobaktam

SORU 33 | Enfeksiyon Hastalıkları | ✓ Kesin Sınav Sırası (#33)

Hücresel İmmün Yetmezlikli Hastalarda Fırsatçı Enfeksiyon Etkenleri

33) T lenfosit aracılı hücresel immün yetmezliği olan bir hastada aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisine bağlı enfeksiyon gelişme riski belirgin olarak artar?

A) Streptococcus pneumoniae

B) Haemophilus influenzae

C) Toxoplasma gondii

D) Neisseria meningitidis

E) Streptococcus pyogenes

SORU 34 | Enfeksiyon Hastalıkları | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #34 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Gebelikte Toxoplasma gondii Enfeksiyonu, Bulaş Yolları ve IgG Avidite Testi

34) Gebelikte ve konjenital enfeksiyonlarda önemli bir etken olan Toxoplasma gondii enfeksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İnsanlara yalnızca kedi tırmalaması yoluyla bulaşır, çiğ veya az pişmiş et tüketimiyle bulaşmaz

B) Gebelikten 6-8 hafta önce geçirilmiş enfeksiyonlarda konjenital toksoplazmoz gelişme riski en yüksektir

C) İyi pişirilmemiş etteki doku kistleri veya kedi dışkısıyla kontamine çiğ sebzelerdeki ookistlerin ağızdan alınmasıyla bulaşır; yüksek IgG aviditesi (>%30) 4 aydan eski enfeksiyonu gösterir

D) Serumda Toxoplasma IgM pozitifliği saptanması her zaman son 2 hafta içinde geçirilmiş akut enfeksiyonu kesin olarak kanıtlar

E) Gebeliğin ilk trimesterinde fetal bulaş oranı en yüksek (%80), ancak fetusta oluşturduğu klinik hasar en hafiftir

SORU 35 – 68 BLOĞU (34 SORU)

Tıbbi Patoloji

25 / 34 Soru Mevcut | 9 Boş Yuva

SORU 35 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#35)

Dokuda Lipit Birikiminin Gösterilmesi (Oil Red O ve Dondurulmuş Kesit)

35) Histopatolojik incelemede hücre içi trigliserit ve lipit birikimini (steatoz) Oil Red O veya Sudan IV boyaları ile güvenle görüntüleyebilmek için doku örneğine aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Rutin alkol ve ksilen takibi sonrası parafin bloktan kesit alınması

B) Parafin kesitlerin deparafinizasyon sonrası yüksek ısıda mikrodalga ile muamele edilmesi

C) Parafin blokların aseton ve kloroform karışımında bekletilerek kesilmesi

D) Taze dokunun kriyostat cihazında dondurularak kesilmesi (Frozen / dondurulmuş kesit)

E) Dokunun rutin parafin takibinden sonra retikülin gümüşleme yöntemiyle boyanması

SORU 36 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#36)

Nekroz Morfolojik Tipleri: Beyin İnfarktı (Sıvılaşma) ve Miyokard İnfarktı (Koagülasyon)

36) Dokularda gelişen hipoksik/iskemik hasar sonucunda ortaya çıkan morfolojik nekroz tipleri ve görüldüğü organ eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Beyin infarktı: Sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Koagülasyon nekrozu

B) Beyin infarktı: Koagülasyon nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Kazeifikasyon nekrozu

C) Beyin infarktı: Yağ nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Sıvılaşma (likefaksiyon) nekrozu

D) Beyin infarktı: Fibrinoid nekroz — Kalp (miyokard) infarktı: Yağ nekrozu

E) Beyin infarktı: Kazeifikasyon nekrozu — Kalp (miyokard) infarktı: Fibrinoid nekroz

SORU 37 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#37)

Reaktif Oksijen Türleri (ROS), Kronik Oksidatif Stres, Kanser ve Hücresel Yaşlanma

37) Hücrelerde reaktif oksijen türlerinin (ROS) artışı ve oksidatif stres durumu kronikleştiğinde aşağıdaki patolojik süreç çiftlerinden hangisi özellikle öne çıkar?

A) Hücre zarında glikojen birikimi ile hipertrofi; lizozomal enzim aktivasyonu ile koagülasyon nekrozu

B) Telomer boyunun uzaması ile replikatif ölümsüzlük; mitokondri biyogenezi ile hiperplazi

C) DNA hasarı ve mutasyon birikimi ile kanser gelişimi; protein ve lipit hasarı ile hücresel yaşlanma

D) Kaspaz kaskadının tam baskılanması ile apoptoz direnci; bazal membran kalınlaşması ile metaplazi

E) Sitozolik kalsiyum azalması ile atrofi; antioksidan enzim artışı ile doku rejenerasyonu

SORU 38 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#38)

Patolojik Hiperplazi ve Neoplazi İlişkisi

38) Hücresel adaptasyon mekanizmalarından biri olan patolojik hiperplazi ile neoplazi arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Patolojik hiperplazide hücre çoğalması otonomdur ve hormonal uyarı kesilse bile gerilemez

B) Patolojik hiperplazi hiçbir zaman malign dönüşüm veya displazi gelişimi için risk oluşturmaz

C) Uyarı ortadan kalktığında hiperplastik büyüme durup gerileyebilir, ancak patolojik hiperplazi neoplazi gelişimi için verimli bir zemin hazırlayabilir

D) Bölünme yeteneği olmayan kalıcı (permanent) hücreler, artmış iş yüküne yalnızca patolojik hiperplazi ile yanıt verir

E) Patolojik hiperplazi, klonal somatik sürücü mutasyonlar sonucu gelişen geri dönüşümsüz bir tümöral süreçtir

SORU 39 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#39)

Hücresel Yaşlanma, Telomeraz Enzimi ve Kanser Hücrelerinde Replikatif Ölümsüzlük

39) Karsinojenez sürecinde tümör hücrelerinde telomeraz enziminin yeniden aktifleşmesinin (reaktivasyonunun) biyolojik önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik hücrelerde her bölünmede telomerlerin hızla kısalmasını sağlayarak apoptozu uyarır

B) Telomer uzunluğunu stabil tutarak replikatif yaşlanma (senesens) sınırını aşar ve hücreye sınırsız çoğalma yeteneği kazandırır

C) P53 ve RB tümör baskılayıcı genlerinin ekspresyonunu artırarak hücreyi G1/S kontrol noktasında durdurur

D) Kromozom uçlarının birbirine yapışmasını (uç uca füzyon) artırarak mitotik katastrofiye yol açar

E) Yalnızca iyi diferansiye benign tümörlerde eksprese olarak metastaz gelişimini engeller

SORU 40 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#40)

Akut Enflamasyonun Morfolojik Kalıpları: Fibrinöz Perikardit ve Organizasyon

40) Akut fibrinöz perikardit seyrinde perikard boşluğunda biriken fibrinöz eksüda fibrinolitik enzimlerle ve makrofajlarla tamamen çözündürülemezse (rezorbe edilemezse) beklenen patolojik sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam rezolüsyon ile perikard yapraklarının hiçbir iz bırakmadan normal histolojik yapısına dönmesi

B) Organizasyon gelişerek granülasyon dokusunun içeri büyümesi, fibröz skarlaşma ve yapışıklık oluşumu

C) Perikard boşluğunda kazeifikasyon nekrozu ve Langhans tipi dev hücreli tüberkül oluşumu

D) Eksüdanın hızla transüdaya dönüşerek hipoproteinemik seröz efüzyon halini alması

E) Epitelioid histiyositlerin proliferasyonu ile non-kazeifiye sarkoid granülomlarının gelişmesi

SORU 41 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#41)

Enflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri: Kompleman Aktivasyon Yolları

41) Kompleman sisteminin aktivasyonunda görev alan 'alternatif yol' ve 'lektin yolu' için doğru başlangıç tetikleyici çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Alternatif yol: Mikrobiyal yüzey molekülleri (LPS, polisakkaritler) — Lektin yolu: Mannoz bağlayıcı lektinin mikrobiyal karbonhidratlara bağlanması

B) Alternatif yol: Antijen-antikor (IgG, IgM) immün kompleksleri — Lektin yolu: Hageman faktörünün (Faktör XII) negatif yüklü kollajene teması

C) Alternatif yol: C1 proteininin IgE antikorlarına bağlanması — Lektin yolu: Lökotrien B4'ün nötrofil reseptörlerini uyarması

D) Alternatif yol: Plazma mannoz bağlayıcı lektinin (MBL) bakteriye bağlanması — Lektin yolu: IgM antikorunun C1q alt birimini aktive etmesi

E) Alternatif yol: Bradikininin endotel reseptörlerine bağlanması — Lektin yolu: Doku faktörünün Faktör VIIa ile kompleks oluşturması

SORU 42 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#42) | **Kronik Enflamasyonun Karakteristik Morfolojik Özellikleri**

42) Kronik enflamasyonun histopatolojik tanı kriterlerini oluşturan üç temel morfolojik özellik aşağıdaki kombinasyonlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yoğun polimorfonükleer nötrofil infiltrasyonu + Vasküler konjesyon ve ödem + Fibrinöz eksüda birikimi

B) Mononükleer hücre infiltrasyonu (makrofaj, lenfosit, plazma hücresi) + Doku yıkımı + Anjiyogenez ve fibrozis ile onarım

C) Eozinofil ve mast hücresi degranülasyonu + İntraepidermal seröz bül oluşumu + Tam rezolüsyon

D) Koagülasyon nekrozu + Trombosit agregasyonu ile Zahn çizgileri + Likide olmuş pürülan apse kavitesi

E) Bazal membran korunduğu için skar bırakmayan epitel rejenerasyonu + Vazodilatasyon + Transüda toplanması

SORU 43 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#43)

Doku Onarımı: Primer ve Sekonder Yara İyileşmesinin Karşılaştırılması

43) Geniş doku kaybı, ülserasyon veya apse sonrası kenarları birleştirilemeyen yaralarda görülen 'sekonder (per secundam) yara iyileşmesi' için primer iyileşmeye kıyasla en tipik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minimal granülasyon dokusu oluşumu ve ince, belirsiz bir skar bırakması

B) İnflamatuar reaksiyonun hiç görülmemesi ve yalnızca bazal tabaka rejenerasyonu ile kapanması

C) Daha yoğun granülasyon dokusu gelişimi, miyofibroblastlarla belirgin yara kontraksiyonu ve geniş skar oluşumu

D) Yara dudaklarının cerrahi sütürle birleştirilmesi ve 24 saat içinde tam epitelizasyonun tamamlanması

E) Kollajen sentezinin ve TGF-beta salınımının baskılanarak yaranın bağ dokusu olmadan iyileşmesi

SORU 44 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#44)

Hemodinamik Bozukluklar: Kronik Pulmoner Konjesyon ve Kalp Yetmezliği Hücreleri

44) Sol kalp yetmezliği veya mitral darlığa bağlı gelişen 'kronik pulmoner konjesyon' tablosunda akciğer parankiminde saptanması en olası histolojik kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alveol septalarında incelme ve yıkım + Alveol boşluklarında nötrofilik pürülan eksüda birikimi

B) Alveol septalarının kalınlaşması ve fibrozisi + Alveol boşluklarında hemosiderin yüklü makrofajların (kalp yetmezliği hücreleri) birikmesi

C) Santral ven ve sinüzoidlerde genişleme + Periportal hepatositlerde yağlı değişiklik (muskat görünümü)

D) Alveol duvarlarında hiyalen membran oluşumu + Tip II pnömositlerde viral sitopatik inklüzyonlar

E) Bronş duvarlarında kazeifiye granülomlar + Alveol lümeninde yoğun eozinofil ve Charcot-Leyden kristalleri

SORU 45 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#45)

Tromboz Patofizyolojisi: Virchow Üçlüsü ve Arteriyel Trombüs Gelişimi

45) Ülserleşmiş bir aterosklerotik plak zemininde gelişen arteriyel tromboz olgusunda, Virchow üçlüsünün hangi bileşenleri birincil ve en uygun patogenetik mekanizmayı oluşturur?

A) Endotel hasarı (subendotelyal ECM ve doku faktörü açığa çıkışı) + Anormal kan akımı (türbülans / girdap akımı)

B) Venöz staz + Normal laminer kan akımının korunması

C) Yalnızca kalıtsal Faktör V Leiden mutasyonu + Venöz kapakçık yetmezliği

D) Antitrombotik prostasiklin (PGI2) ve nitrik oksit (NO) artışı + Fibrinolitik t-PA salınımı

E) İzole venöz staz + Trombosit GpIb ve GpIIb/IIIa reseptörlerinin konjenital eksikliği

SORU 46 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#46)

Septik Şok ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon: Waterhouse-Friderichsen Sendromu

46) Ağır bakteriyel sepsis (özellikle Neisseria meningitidis'e bağlı fulminan meningokoksemi) ve dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) seyri sırasında gelişen iki taraflı masif adrenal bez kanaması (hemorajik nekroz) ve akut adrenal korteks yetmezliği tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Waterhouse-Friderichsen sendromu

B) Goodpasture sendromu

C) Cushing sendromu

D) Conn sendromu

E) Sheehan sendromu

SORU 47 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#47)

Tip IV (Hücresel / Gecikmiş Tip) Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Mekanizması

47) Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonlarının immünopatogenezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?

A) Dolaşan antijen-antikor (immün) komplekslerinin damar duvarında birikmesiyle gelişir

B) Mast hücreleri yüzeyine bağlı IgE antikorlarının antijenle çapraz bağlanması aracılıdır

C) Duyarlılaşmış T lenfositler aracılıdır, patogenezde antikorların rolü yoktur

D) Hücre yüzey antijenlerine karşı gelişen sadece IgG ve IgM antikorları ile ortaya çıkar

E) Antijenle karşılaşmadan sonraki ilk 15-30 dakika içinde gelişen hızlı vasküler permeabilite artışıyla karakterizedir

SORU 48 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#48)

Marfan Sendromu (FBN1 Mutasyonu) ve Kardiyovasküler Komplikasyonları

48) Fibrillin-1 (FBN1) gen mutasyonu sonucu gelişen Marfan sendromunda yaşamı en çok tehdit eden ve en sık ölüm nedeni olan majör kardiyovasküler komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner kapak stenozu

B) Mitral anülüs kalsifikasyonu

C) Atriyal septal defekt (ASD)

D) Konstriktif perikardit

E) Aort anevrizması ve aort diseksiyonu

SORU 49

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 50 | Tıbbi Patoloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #50 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Endokrin Neoplazilerde Diferansiyasyon ve Fonksiyonel Hormon Üretimi

50) Endokrin bezlerden köken alan neoplazilerde fonksiyonel hormon üretimi ve klinik endokrin hiperfonksiyon sendromlarının gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hormon üretimi yalnızca uzak metastaz yapmış anaplastik karsinomlarda görülür

B) Fonksiyonel hormon üretimi, köken aldığı normal dokuya çok benzeyen iyi diferansiye benign endokrin tümörlerde (adenomlarda) daha tipiktir

C) Tümörde diferansiyasyon kaybı (anaplazi) arttıkça köken aldığı bezin özgül hormonunu sentezleme kapasitesi de doğru orantılı olarak artar

D) Benign endokrin adenomlar hiçbir zaman hormon salgılamaz ve yalnızca bası semptomlarıyla klinik verir

E) Endokrin organların hiperfonksiyonu yalnızca inflamatuar nekroz süreçlerinde görülür, neoplazilerde görülmez

SORU 51 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#51)

Li-Fraumeni Sendromu (Kalıtsal TP53 Mutasyonu) Tümör Spektrumu

51) Kalıtsal TP53 tümör baskılayıcı gen mutasyonu sonucu otozomal dominant kalıtılan Li-Fraumeni sendromu ile en uyumlu klinik tümör kümelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarkomlar, meme karsinomu, akut lösemi ve beyin tümörleri

B) Retinoblastom ve osteosarkom

C) Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma ve paratiroid hiperplazisi

D) Serebellar hemanjiyoblastom, berrak hücreli renal karsinom ve feokromositoma

E) Kolon adenokarsinomu, endometriyum karsinomu ve over karsinomu

SORU 52

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 53

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 54 Tıbbi Patoloji ✓ Kesin Sınav Sırası (#54)

Minimal Değişiklik Hastalığı (Lipoid Nefroz) Morfolojik Bulguları

54) Çocukluk çağında nefrotik sendromun en sık nedeni olan minimal değişiklik hastalığı (lipoid nefroz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bowman boşluğunda ve proksimal tübüllerde yaygın hücresel kresent (yarımay) birikimi izlenir

B) Proksimal tübül bazal membranında yaygın distrofik kalsifikasyon birikimi görülür

C) Proksimal tübül epitel hücrelerinde reabsorbe edilen protein (hyalin) damlacıkları ve lipit birikimi görülür

D) İmmünfloresan mikroskopide glomerül ve tübül bazal membranında lineer IgG ve C3 birikimi saptanır

E) Işık mikroskopisinde glomerül bazal membranında yaygın çift kontur (tren rayı) kalınlaşması izlenir

SORU 55 Tıbbi Patoloji ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #55 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Akut Nefritik Sendromun Karakteristik Klinik ve Laboratuvar Bulguları

55) Aşağıdakilerden hangisi akut nefritik sendromun tipik klinik ve idrar bulgularından biridir?

A) Masif proteinüri (>3,5 g/gün) ve lipidüri

B) İzole hiperlipidemi ve deri ksantomları

C) İzole renal glukozüri ve ketonüri

D) Hematüri (dismorfik eritrositler) ve idrarda eritrosit silendirleri

E) İzole hipokalsemi ve hipoparatiroidik tetani

SORU 56

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 57 Tıbbi Patoloji ✓ Kesin Sınav Sırası (#57) **Akut Piyelonefrit Histopatolojik Bulguları**

57) Akut piyelonefritin karakteristik mikroskobik (histopatolojik) bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerüllerde Bowman boşluğunu dolduran yaygın fibroépitelyal kresent oluşumu

B) Tübüllerde ve interstisyumda nötrofilden zengin süpüratif enflamasyon (nötrofilik tübülit ve apseleşme)

C) Tübüllerin eozinofilik hyalin silendirlerle genişleyerek tiroid folliküllerine benzemesi (tiroidizasyon)

D) Glomerül kapiller yumaklarında Kimmelstiel-Wilson nodüler mezangiyal skleroz odakları

E) İnterstisyumda yalnızca lenfosit, plazma hücresi ve eozinofillerden oluşan granülomatöz infiltrasyon

SORU 58

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 59 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#59)

Renal Hücreli Karsinomun (RCC) En Sık Görülen Histolojik ve Moleküler Alt Tipleri

59) Renal tübül epitelinden köken alan renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen 3 ana histolojik ve moleküler alt tipi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Onkositoma, Wilms tümörü, Anjiyomiyolipom

B) Berrak hücreli, Papiller, Kromofob

C) Papiller, Wilms tümörü, Kromofob

D) Berrak hücreli, Onkositoma, Kromofob

E) Kromofob, Anjiyomiyolipom, Berrak hücreli

SORU 60 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#60)

Genital Herpes Simpleks Virüs (HSV) Enfeksiyonu Histopatolojik Bulguları

60) Genital Herpes Simpleks Virüs (HSV) enfeksiyonunun mikroskobik incelemesinde saptanan en tipik histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skuamöz epitelde koilositoz ve belirgin perinükleer halo

B) Cowdry Tip A intranükleer inklüzyon ve çok çekirdekli (multinükleer) dev hücre

C) Damar duvarında plazma hücreleriyle çevrili proliferatif endarterit

D) Nekrotizan granülom ile oluşan yıldızsı (stellat) apse

E) Lamina propria içinde izlenen germinal merkezli lenfoid follikül

SORU 61 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#61)

Vulvovajinal Kandidiyazis (Candida Enfeksiyonu) Özellikleri

61) Kadın genital sisteminde sık görülen vulvovajinal kandidiyazis (Candida albicans enfeksiyonu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etken olan Candida albicans, sağlıklı kadınların bir kısmında normal vajinal ve gastrointestinal florada kommensal olarak bulunabilir

B) Diabetes mellitus, gebelik, oral kontraseptif ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı hastalık gelişimine zemin hazırlar

C) Klinikte şiddetli vulvovajinal kaşıntı ve beyaz, süt kesiği (peynir kesiği) görünümünde koyu kıvamlı akıntı ile karakterizedir

D) Cinsel yolla bulaşan klasik bir enfeksiyon olduğundan asemptomatik vakalarda dahi tüm cinsel partnerlerin rutin tedavisi zorunludur

E) Mikroskobik incelemede tomurcuklanan maya hücreleri (blastosporlar) ve psödohif yapıları izlenir

SORU 62

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 63 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#63)

Endometriyal Hiperplazi Güncel Sınıflaması: İki Ana Formu (Atipisiz ve Atipili Hiperplazi / EIN)

63) Güncel Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre endometriyal hiperplazinin klinik ve morfolojik olarak ayrıldığı iki ana formu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük dereceli (LSIL) ve yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL)

B) Seröz hiperplazi ve berrak hücreli hiperplazi

C) Atipisiz hiperplazi ve atipili hiperplazi (endometriyal intraepitelyal neoplazi - EIN)

D) Akut hiperplazi ve kronik hiperplazi

E) Papiller hiperplazi ve kromofob hiperplazi

SORU 64

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 65

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 66

Tıbbi Patoloji (35–68) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 67 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#67)

Meme Başı Paget Hastalığı Patogenezi ve Klinik Önemi

67) Meme başı Paget hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Meme başı derisinin skuamöz epitel hücrelerinden köken alan tamamen benign bir ekzemadır

B) Meme başı ve areola derisinde malign Paget hücreleri izlenir ve altında sıklıkla duktal karsinoma in situ (DCIS) veya invaziv meme karsinomu bulunur

C) Hastaların tamamında östrojen reseptörü (ER) pozitif, HER2 (c-erbB2) negatif lobüler karsinom ile ilişkilidir

D) Meme stromasındaki intralobüler bağ dokusundan gelişen bifazik fibroépitelyal bir tümördür

E) Yalnızca emzirme dönemindeki genç kadınlarda Staphylococcus aureus enfeksiyonuna bağlı gelişir

SORU 68 | Tıbbi Patoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#68)

Prostat Adenokarsinomu Histopatolojik Tanı Kriterleri (Bazal Hücre Tabakasının Kaybı)

68) Prostat iğne biyopsisinde prostat adenokarsinomunu histopatolojik olarak benign prostat bezlerinden ve benign prostat hiperplazisinden (BPH) ayıran en temel mikroskobik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bez lümenlerinde konsantrik lameller yapıda corpora amylacea görülmesi

B) Prostat bezlerindeki dış bazal hücre tabakasının kaybolması (tek sıralı atipik sekretuvar hücre dizilimi)

C) Prostatın transizyonel (periüretral) zonunda fibromüsküler stromal nodüllerin oluşması

D) Bez epitelinin lümene doğru papiller katlantılar yapan çift katlı hücre sırasıyla döşenmesi

E) İmmünohistokimyasal incelemede bez çevresinde p63 ve yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMWCK) pozitifliğinin korunması

SORU 69 – 78 BLOĞU (10 SORU)

Halk Sağlığı

6 / 10 Soru Mevcut | 4 Boş Yuva

SORU 69 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#69)

Anne Sütü, Bebek Beslenmesi ve Türkiye Doğurganlık Göstergeleri

69) Anne sütü, bebek-çocuk beslenmesi ve Türkiye'nin güncel demografik sağlık göstergeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin besin ihtiyacının %100'ünü, 6-12. aylar arasında ise %50'sini karşılar. II. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı (TDH) nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altına gerileyerek 1,42 düzeyine düşmüştür. III. Anne sütündeki demirin biyoyararlanımı yüksek olup yaklaşık %50-60'ı bağırsaklardan emilir. IV. D vitamini veya demir eksikliği gelişen bebeklerde ön fontanel normalden daha erken ve hızlı kapanır.

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

SORU 70

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 71 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#71)

Gebelikte Bağışıklama ve Kontrendike Olmayan Aşılar (Tetanoz / Td)

71) Gebelik döneminde maternal ve neonatal bağışıklama kapsamında rutin olarak uygulanan ve gebede yapılması kontrendike olmayan aşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızamıkçık (Rubella) aşısı

B) Suçiçeği (Varisella) aşısı

C) Kızamık (Measles) aşısı

D) BCG (Verem) aşısı

E) Tetanoz (Td / Tdap) aşısı

SORU 72

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 73

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 74 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#74)

Bebeklik Döneminde Büyümenin İzlenmesi ve Ağırlık Artışı Kuralları

74) Doğum ağırlığı 2500 gram olan sağlıklı bir bebeğin normal büyüme eğrisine göre 6. ayda ve 1. yaşın (12. ayın) sonunda ulaşması beklenen vücut ağırlığı sırasıyla kaç kilogramdır?

A) 4 kg ve 6 kg

B) 5 kg ve 7,5 kg

C) 5 kg ve 10 kg

D) 6 kg ve 9 kg

E) 7,5 kg ve 10 kg

SORU 75 | Halk Sağlığı | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #75 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Kişiye ve Çevreye Yönelik Hizmetlerin Ayrımı

75) Koruyucu sağlık hizmetleri 'kişiye yönelik' ve 'çevreye yönelik' koruyucu sağlık hizmetleri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alır?

A) Kişisel hijyen ve sağlık eğitimi

B) Bağışıklama (aşılama) hizmetleri

C) Erken tanı ve tarama programları

D) Kemoprofilaksi (ilaçla koruma)

E) Besin kontrolü ve gıda güvenliği (su ve besin sanitasyonu)

SORU 76 | Halk Sağlığı | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #76 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Türkiye'de Halk Sağlığının Tarihçesi ve Sosyalleştirme Kanunu (Prof. Dr. Nusret Fişek)

76) Türkiye'de modern anlamda halk sağlığı ve toplum hekimliği kavramının yerleşmesine öncülük eden, 1961 tarihli 224 sayılı 'Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'un mimarı olan ve Hıfzıssıhha Okulu ile Hacettepe Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dr. Refik Saydam

B) Prof. Dr. Nusret Fişek

C) Dr. Behçet Uz

D) Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet

E) Dr. Besim Ömer Akalın

SORU 77

Halk Sağlığı (69–78) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 78 | Halk Sağlığı | ✓ Kesin Sınav Sırası (#78)

Anne Sütü ve İnek Sütü Protein Bileşimi Farkları (Beta-Laktoglobulin)

78) İnek sütünde yüksek oranda bulunan ve bebeklerde inek sütü protein alerjisinin en önemli nedeni olan, ancak insan anne sütünde doğal olarak bulunmayan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfa-laktalbümin

B) Laktoferrin

C) Salgısal immünglobulin A (sIgA)

D) Lizozim

E) Beta-laktoglobulin

SORU 79 – 90 BLOĞU (12 SORU)

Üroloji

8 / 12 Soru Mevcut | 4 Boş Yuva

SORU 79 **Üroloji (79–90)** Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 80 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#80)

Monosemptomatik Enürezis Nokturnada Birinci Basamak Farmakolojik Tedavi (Desmopresin)

80) Gündüz işeme semptomu bulunmayan (monosemptomatik) enürezis nokturna tanısı alan 7 yaşındaki erkek çocukta uygulanan birinci basamak medikal (farmakolojik) tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Desmopresin (dDAVP)

B) İmipramin

C) Oksibutinin

D) Tamsulosin

E) Mirabegron

SORU 81 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#81)

Proteinüri Sınıflaması ve Prerenal (Taşma / Overflow) Proteinüri Nedenleri

81) İdrar tetkikinde saptanan proteinürinin fizyopatolojik sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi prerenal (taşma / overflow) proteinüri nedenlerinden biridir?

A) Normal gebelik

B) Akut glomerülonefrit

C) Nefritik sendrom

D) Multipl miyelom (veya rabdomiyolize bağlı miyoglobinüri / intravasküler hemoliz)

E) Fanconi sendromu

SORU 82 | Üroloji (79–90) | Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 83 | Üroloji (79–90) | Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 84 | Üroloji (79–90) | Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 85 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#85)

Obstrüktif Üropatide Supravezikal ve İnfravezikal Nedenlerin Ayrımı (Fimozis)

85) Aşağıdaki obstrüktif üropati patolojilerinden hangisi mesane çıkışı ve altını etkileyen infravezikal (alt üriner sistem) obstrüksiyon nedenleri arasında yer alır?

A) Renal kist

B) Üreteral valv

C) Gebelik

D) Fimozis

E) Renal arter anevrizması

SORU 86 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#86)

Alt Üriner Sistem Obstrüksiyonunda Mesane Evreleri (Kompansasyon Evresi)

86) Alt üriner sistem (infravezikal) obstrüksiyonunda mesanenin verdiği fizyopatolojik yanıtın evreleri değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi kompansasyon evresinin özelliğidir?

A) Detrüsor kasında ilk kez hipertrofi başlaması (irritasyon evresi bulgusudur)

B) Mesane aşırı hassasiyeti ve sıkışma tipi inkontinansın başlaması (irritasyon evresi bulgusudur)

C) Mesane duvarının incelerek atonisi ve taşma (overflow) inkontinansı gelişmesi (dekompansasyon evresi bulgusudur)

D) Artmış işeme basıncı sayesinde mesanenin tam boşalması ve mesanede rezidüel idrar kalmaması

E) Üreterovezikal sfinkter mekanizmasının bozularak sekonder vezikoüreteral reflü gelişmesi

SORU 87 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#87)

Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İdrar Örneği Alma Yöntemleri ve Kontaminasyon Riski

87) Üriner sistem enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında kullanılan idrar örneği alma yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdrar örneği orta akım idrarı, üretral kateterizasyon veya suprapubik aspirasyon yöntemleriyle alınabilir

B) Orta akım idrar örneği alınırken periüretral ve genital bölge florasından kaynaklanan kontaminasyon riski mevcuttur

C) Mesane kontrolü henüz gelişmemiş bebeklerde kullanılan yapıştırma torba yöntemi yüksek yanlış pozitiflik oranına sahiptir

D) Üretral kateterizasyon ile örnek alınması kontaminasyon riskini orta akım idrara göre azaltır ancak iyatrojenik enfeksiyon riski taşır

E) Suprapubik aspirasyon yöntemi, periüretral bakteriyel kontaminasyona en açık olan örnekleme yöntemidir

SORU 88 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#88)

Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanımlamaları (Komplike vs Komplike Olmayan, Rekürren, Persistans)

88) Üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSE) kullanılan klinik tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Rekürren enfeksiyonlar, başarılı bir tedavinin ardından aynı veya farklı bir mikroorganizma ile tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarıdır

B) Re-enfeksiyon, geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından üriner sistem dışından yeni/farklı bir patojenle tekrar enfekte olunmasıdır

C) Bakteriyel persistans, tedavi sonrası iki haftadan kısa sürede üriner sistem içindeki bir odaktan aynı patojenle enfeksiyonun tekrarlamasıdır

D) Nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyonlar, genellikle Pseudomonas veya antimikrobiyallere dirençli suşların neden olduğu enfeksiyonlardır

E) Anatomik ya da yapısal bir anomalisi bulunmayan hastalarda gelişen üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonları denir

SORU 89 | Üroloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#89)

Alt Üriner Sistem Semptomları (Depolama vs İşeme / Boşaltma Semptomları)

89) Aşağıdaki alt üriner sistem semptomlarından (AÜSS) hangisi mesanenin depolama (irritatif) semptomlarından biri değildir?

A) Sık idrara çıkma (Pollakiüri / Frequency)

B) Gece idrara kalkma (Noktüri)

C) Ani sıkışma hissi (Urgency)

D) Sıkışma tipi idrar kaçırma (Urge inkontinans)

E) Aralıklı (kesik kesik) idrar akımı (İntermittency)

SORU 90 | Üroloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #90 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısında İdrar Kültürü Anlamlı Koloni Sayısı Eşik Değerleri

90) Semptomatik bir hastada üriner sistem enfeksiyonu tanısı koymak amacıyla alınan idrar kültüründe, idrar örneği alma yöntemlerine göre anlamlı bakteriüri kabul edilen koloni sayısı (CFU/mL) eşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Orta akım idrarda ≥ 10^5 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^4 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda herhangi bir sayıda Gram-negatif basil (veya > 10^3 CFU/mL Gram-pozitif kok) üremesi

B) Orta akım idrarda ≥ 10^2 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda ≥ 10^5 CFU/mL üreme

C) Orta akım idrarda ≥ 10^3 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, suprapubik aspirasyonda ≥ 10^4 CFU/mL üreme

D) Orta akım idrarda, üretral kateterizasyonda ve suprapubik aspirasyonda yalnızca ≥ 10^6 CFU/mL üreme

E) Suprapubik aspirasyonda ≥ 10^5 CFU/mL, üretral kateterizasyonda ≥ 10^3 CFU/mL, orta akım idrarda herhangi bir sayıda üreme

SORU 91 – 96 BLOĞU (6 SORU)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 / 6 Soru Mevcut | 3 Boş Yuva

SORU 91 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#91)

Spontan Abortus Klinik Tipleri ve Ultrasonografik Bulguları (İnkomplet Abortus)

91) Vajinal kanama ve kramp tarzında kasık ağrısı şikayetiyle başvuran G2P1 gebe hastanın yapılan pelvik muayenesinde servikal os açık saptanıyor. Transvajinal ultrasonografide intrauterin kavitede servikse yakın yerleşimli, düzensiz konturlu gestasyonel kese ve trofoblastik doku artıkları izlenirken embriyo izlenmiyor. Bu hastada en olası düşük (abortus) tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abortus imminens (Düşük tehdidi)

B) Komplet abortus (Tam düşük)

C) İnkomplet abortus (Tam olmayan düşük)

D) Tekrarlayan gebelik kaybı (Habitüel abortus)

E) Missed abortus (Ölü gebelik ürününün içeride kalması)

SORU 92

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 93 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#93)

Obstetrik Öyküde Gravida, Parite, Yaşayan ve Abortus (GPYA) Hesaplaması

93) Otuz yaşında, toplam 4 gebelik öyküsü bulunan bir kadının obstetrik anamnezinde; 36. ve 38. gebelik haftalarında doğmuş ve halen yaşayan 2 çocuğu ile 16. ve 25. gebelik haftalarında sonlanmış 2 gebelik kaybı olduğu öğreniliyor. Bu hastanın obstetrik GPYA (Gravida - Parite - Yaşayan - Abortus) sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) G4 P2 Y2 A2

B) G4 P3 Y2 A1

C) G4 P2 Y4 A2

D) G2 P2 Y2 A2

E) G4 P4 Y2 A0

SORU 94 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | ✓ Kesin Sınav Sırası (#94)

Antenatal Fetal İyilik Hali Değerlendirme Testleri ve Doppler USG

94) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi gebelikte antenatal fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerden biri değildir?

A) Non-stres test (NST - Fetal kalp hızı reaktivitesinin izlenmesi)

B) Biyofizik profil (BFP - NST, fetal solunum, hareket, tonus ve amniyon sıvı hacmi)

C) Kontraksiyon stres testi (KST - Oksitosin yükleme testi)

D) Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografisi

E) Renal arter Doppler ultrasonografisi ile maternal böbrek perfüzyonunun incelenmesi

SORU 95

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 96

Kadın Hastalıkları ve Doğum (91–96)

Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 97 – 100 BLOĞU (4 SORU)

Tıbbi Farmakoloji

3 / 4 Soru Mevcut | 1 Boş Yuva

SORU 97 | Tıbbi Farmakoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#97)

İmmünosüpresif İlaçlar: Takrolimusun Etki Mekanizması (FKBP-12 ve Kalsinörin İnhibisyonu)

97) Böbrek nakli yapılan bir hastada akut greft reddini önlemek ve T lenfosit aktivasyonunu baskılamak amacıyla başlanan takrolimusun (FK506) temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) mTOR kinazı inhibe ederek IL-2 reseptör uyarısı sonrası hücre döngüsü yanıtını engellemesi

B) Dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek pürin ve DNA sentezini azaltması

C) Hücre içi FKBP-12 proteinine bağlanarak kalsinörin fosfatazı inhibe etmesi ve IL-2 transkripsiyonunu baskılaması

D) Aktive T lenfosit yüzeyindeki IL-2 reseptörünün alfa alt birimini (CD25) bloke etmesi

E) Makrofajlardan TNF-alfa salınımını uyararak T hücre apoptozunu hızlandırması

SORU 98 | Tıbbi Farmakoloji | ≈ Branş İçi Yerleşim (Soru #98 · Numarası Teyit Edilmemiş)

Hidroksiklorokin Yan Etkileri ve Retinopati (Oftalmolojik Muayene) Takibi

98) Sistemik lupus eritematozus (SLE) tanısıyla uzun süreli antimalaryal bir ilaç olan hidroksiklorokin kullanan bir hastanın rutin ilaç güvenliği takibinde aşağıdaki incelemelerden hangisinin düzenli olarak yapılması gereklidir?

A) Oftalmolojik (retina ve görme alanı) muayene

B) Rutin transbronşiyal akciğer biyopsisi

C) Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D) Aylık seri kardiyak troponin testi

E) Rutin karaciğer iğne biyopsisi

SORU 99

Tıbbi Farmakoloji (97–100) Bu soru numarası için henüz hatırlanan soru metni paylaşılmamıştır — **BOŞ BIRAKILDI**

SORU 100 | Tıbbi Farmakoloji | ✓ Kesin Sınav Sırası (#100)

Monoklonal Antikorlar: RANKL İnhibitörü Denosumab ve Osteoklast İnhibisyonu

100) Postmenopozal osteoporoz ve kemik metastazlarına bağlı kemik kaybının tedavisinde kullanılan; RANK ligandına (RANKL) yüksek afiniteyle bağlanarak osteoklastların oluşumunu, fonksiyonunu ve sağkalımını inhibe eden tam insan IgG2 monoklonal antikoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denosumab

B) Siklosporin

C) Rituksimab

D) Trastuzumab

E) Omalizumab

🔑 2026–2027 Dönem 3 Kurul 1 Cevap Anahtarı (1–100 Sınav Düzeni)

Not: Yanında * işareti bulunan soru numaraları (12 adet), WhatsApp konuşmalarında branşı ve içeriği paylaşılan ancak kesin soru numarası belirtilmediği için ilgili branşın ders sırasına göre boş yuvalara yerleştirilen sorulardır. – ile gösterilen 36 yuva henüz paylaşılmamış (boş) soruları temsil eder.

1. —	2. B	3. —	4. E	5. —
6. B	7. —	8. D	9. —	10. A*
11. —	12. —	13. —	14. E	15. —
16. A*	17. C	18. —	19. D*	20. E
21. —	22. D	23. E	24. —	25. E*
26. —	27. A*	28. —	29. E	30. —
31. B	32. C	33. C	34. C*	35. D
36. A	37. C	38. C	39. B	40. B
41. A	42. B	43. C	44. B	45. A
46. A	47. C	48. E	49. —	50. B*
51. A	52. —	53. —	54. C	55. D*
56. —	57. B	58. —	59. B	60. B
61. D	62. —	63. C	64. —	65. —
66. —	67. B	68. B	69. D	70. —
71. E	72. —	73. —	74. B	75. E*
76. B*	77. —	78. E	79. —	80. A
81. D	82. —	83. —	84. —	85. D
86. D	87. E	88. E	89. E	90. A*
91. C	92. —	93. B	94. E	95. —
96. —	97. C	98. A*	99. —	100. A